

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5070370-07.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ADRIANA MENEZES DE REZENDE

RECORRENTE: AGATHA MACHADO GOMES

RECORRENTE: RAVI MACHADO SANTOS PEREIRA

RECORRIDO: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

RECORRIDO: MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO

RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

AGRAVO/MEDIDA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA. CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO À SAÚDE. MEDIDA DE URGÊNCIA. ALERGIA À PROTEÍNA DO LEITE DE VACA (APLV). REFLUXO GASTRO-ESOFÁGICO. NECESSIDADE DE SUPLEMENTO ALIMENTAR. FÓRMULAS COM AMINOÁCIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. NECESSIDADE NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

ACÓRDÃO

A 6ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, mantendo a decisão do evento 3. Sem custas, nem honorários nos termos do art. 55 da lei nº 9.099/95, por se tratar de recurso contra decisão interlocutória. Intimem-se e, após o trânsito em julgado, devolvam-se os autos ao juízo de origem. É como voto, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 16 de outubro de 2024.

5070370-07.2024.4.02.5101

510014564719 .V3

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5070370-07.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ADRIANA MENEZES DE REZENDE

RECORRENTE: AGATHA MACHADO GOMES

RECORRENTE: RAVI MACHADO SANTOS PEREIRA

RECORRIDO: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

RECORRIDO: MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO

RECORRIDO: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

RELATÓRIO

Trata-se de medida de urgência (agravo de instrumento) interposta pela parte autora em face de decisão dos autos originários, na qual o Juízo a quo indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela para concessão do insumo Suplemento Nutricional Neocate.

Sustenta a recorrente que apresenta gastroquise simples com alergia a proteína do leite de vaca (APLV), apresentando sintomas de vômitos, diarreia e perda de peso, necessitando de dieta especial com o referido complemento alimentar.

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Inicialmente, o direito à saúde dentro do rol de direitos humanos, foi reconhecido mundialmente, por meio da Declaração Universal dos Direitos humanos de 1948, que em seu artigo XXV garantia a toda pessoa o direito a um padrão de vida que fosse capaz de assegurar a si e a sua família saúde e bem estar.

O art. 196, da CF/88, norma de aplicabilidade plena, declara o direito à saúde: “A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às

ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.”

De pronto, algumas leis específicas deixam bastante clara a responsabilidade do SUS de fornecer insumos à população vulnerável, como ocorre no caso dos diabéticos, amparados pela Lei 11.347/2006 e pela portaria 2.583/2007.

A Lei 11.347/2006 é clara ao tratar de seu objeto:

Dispõe (a Lei) sobre a distribuição gratuita de medicamentos e materiais necessários à sua aplicação e à monitoração da glicemia capilar aos portadores de diabetes inscritos em programas de educação para diabéticos.

Art. 1º Os portadores de diabetes receberão, gratuitamente, do Sistema Único de Saúde - SUS, os medicamentos necessários para o tratamento de sua condição e os materiais necessários à sua aplicação e à monitoração da glicemia capilar.

§ 1º O Poder Executivo, por meio do Ministério da Saúde, selecionará os medicamentos e materiais de que trata o caput, com vistas a orientar sua aquisição pelos gestores do SUS.

Já a portaria 2.583/2007 também ressalta que:

Define (a portaria) elenco de medicamentos e insumos disponibilizados pelo Sistema Único de Saúde, nos termos da Lei nº 11.347, de 2006, aos usuários portadores de diabetes mellitus.

Art. 1º Definir o elenco de medicamentos e insumos que devem ser disponibilizados na rede do Sistema Único de Saúde, destinados ao monitoramento da glicemia capilar dos portadores de diabetes mellitus, nos termos da Lei Federal nº 11.347, de 2006.

II - INSUMOS:

a) seringas com agulha acoplada para aplicação de insulina;

b) tiras reagentes de medida de glicemia capilar; e

c) lancetas para punção digital.

Para além de leis pontuais, entretanto, o RENAME, a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais traz, em diversos pontos de seu longo texto, menções a insumos. O RENAME é, basicamente, a lista de medicamentos fornecidos pelo Poder Público aos necessitados através do SUS. Se se compreende, tal como se deve ser compreendido, que os medicamentos listados no RENAME são de responsabilidade do SUS, também os insumos deverão ser, de maneira que, pela leitura da Relação, é possível afirmar que o fornecimento de insumos integra, de fato, o SUS.

Para deixar claro o ponto anterior, alguns excertos do texto são trazidos para a presente discussão:

PORTARIA Nº 3.047, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2019

Estabelece a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais - Rename 2020 no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) por meio da atualização do elenco de medicamentos e insumos da Relação Nacional de Medicamentos Essenciais - Rename 2018.

Art. 1º Fica estabelecida a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais - Rename 2020 no âmbito do SUS, por meio da atualização do elenco de medicamentos e insumos da Relação Nacional de Medicamentos Essenciais - Rename 2018.

SEÇÃO A - RENAME POR ANEXOS

Anexo IV - Relação Nacional de Insumos

A Relação Nacional de Insumos é composta por produtos para a saúde, de acordo com programas do Ministério da Saúde. Os itens desta relação integram os componentes Básico e Estratégico da Assistência Farmacêutica, conforme apontado no campo “Componente” das seções B e C.

Com relação ao tema, segue posicionamento do STJ acerca da responsabilidade dos entes federativos em fornecer insumos da saúde:

ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA TRATAMENTO MÉDICO. INEXISTÊNCIA DE INVASÃO DA COMPETÊNCIA DO EXECUTIVO. ACÓRDÃO DE ORIGEM DIVERGENTE DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, conforme premissa contida no art. 196 da Constituição Federal. 2. Ainda, considerando-se que o Sistema Único de Saúde é financiado pela União, Estados-membros, Distrito Federal e Municípios, nos termos do art. 198, § 1º, da Constituição Federal, pode-se afirmar que é solidária a responsabilidade dos referidos entes no cumprimento dos serviços públicos de saúde prestados à população. 3. Desse modo, fica claro o entendimento de que a responsabilidade em matéria de saúde, seja pela distribuição gratuita de medicamentos, seja pelo fornecimento de insumos em favor de pessoas carentes, é do Estado, compreendidos aí todos os entes federativos. 4. A falar do defendido pela decisão monocrática, foram transcritas as ementas dos seguintes julgados: REsp 1.645.846/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, 2ª Turma, DJe

20/4/2017; AgRg no Ag 1424474/BA, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 22/8/2013; EDcl no AREsp 240.955/SC, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 20/8/2013 e AgRg no REsp 1284271/SC, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 02/8/2013. 5. O Tribunal de origem não se baseou no caso concreto, mas adotou tese jurídica divergente da sedimentada no STJ, como demonstra o seguinte excerto: "A solução para tais entraves da saúde pública não compete ao Poder Judiciário, não podendo este se imiscuir na esfera de competência do Poder Executivo, impondo que um determinado tratamento deva ser posto à disposição da parte Autora, minorando seu sofrimento e agravando, provavelmente, de outros". 6. Portanto, deduz-se que o acórdão de origem não está em sintonia com o atual entendimento do STJ, razão pela qual se deu parcial provimento ao Recurso Especial, determinando-se o exame do direito ao tratamento pleiteado no caso concreto. O mérito acerca da necessidade do home care no caso concreto será examinado pelo Tribunal de origem. 7. Agravo Interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1784258 RJ 2018/0284315-0, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 19/09/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/10/2019)

Desse modo, fica claro o entendimento de que a responsabilidade em matéria de saúde, seja pela distribuição gratuita de medicamentos, seja pelo fornecimento de insumos em favor de pessoas carentes, é do Estado, compreendidos aí todos os entes federativos.

No caso dos autos, a parte autora, de acordo com o laudo médico datado de 08/07/2024, não consegue tolerar dietas com fórmula extensamente hidrolisada. Por essa razão, foi prescrito o uso de uma fórmula à base de aminoácidos, especificamente o suplemento alimentar Neocate. Conforme laudo médico, a Gastroquise Simples (CID: Q79.3) é uma malformação da parede abdominal anterior, de causa ainda desconhecida, que apresentou aumento da incidência no mundo todo nos últimos anos. A APLV é uma reação alérgica ao leite de vaca e a seus derivados, que pode causar uma variedade de sintomas gastrointestinais, dermatológicos e respiratórios. Em bebês e crianças pequenas, isso pode causar sintomas como diarreia, vômito, erupções cutâneas e desconforto abdominal.

Ocorre que, no parecer do NAT, este informa que, em lactentes a partir dos 6 meses de idade (idade atual do autor - Evento 1, ANEXO2, Página 1) é recomendado pelo Ministério da Saúde o início da introdução da alimentação complementar, nessa fase, ocorre a substituição gradual das refeições lácteas por alimentos in natura (cereais, raízes e tubérculos; feijões; carnes e ovos; legumes, verduras e frutas). Aos 6 meses é indicado a introdução de duas papas de fruta (colação e lanche da tarde) e uma papa salgada (almoço), sendo indicada a realização de 4 refeições lácteas de 180 a 200ml (720-800ml/dia). Ao completar 7 meses de idade, é esperado que o lactente introduza a segunda papa salgada (jantar), sendo recomendadas 3 refeições lácteas de 180 a 200ml, totalizando o consumo máximo 600ml/dia⁹. Destaca-se que volumes lácteos acima do recomendado acabam mantendo criança saciada e, conseqüentemente, com menor apetite para os demais grupos alimentares.

Desta forma, não se estando, neste momento, a negar no mérito o referido insumo ao autor, mas apenas em fase de cognição sumária, entendo que não há demonstração de que o referido insumo é a única forma de alimentar o autor, sendo certo que, em uma primeira vista, o parecer do NATJUS demonstra uma via alternativa mais natural e adequada para o crescimento do autor do que um insumo fabricado em laboratório.

Vale ressaltar que, neste momento, apenas se está em analisar a tutela de urgência, com base nos documentos até então juntado nos autos, sendo certo que a parte autora, em rito célere de juizado, ainda terá a oportunidade de provar seu direito.

Isso posto, estando ausentes os requisitos autorizadores da concessão da antecipação dos efeitos da tutela pleiteada, quais sejam, o *fumus boni iuris* decorrente do direito constitucional à saúde e da necessidade do medicamento para a autora e o *periculum in mora*, em razão da urgência do estado da parte, entendo que a tutela não deve ser concedida no presente momento.

Portanto, não preenchidos os pressupostos autorizadores da antecipação de tutela previstos no art. 300 do CPC e entendo que os argumentos da parte autora não são suficientes a gerar a revisão de plano da decisão proferida pelo Juízo de origem.

Ante o exposto, voto por CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, mantendo a decisão do evento 3. Sem custas, nem honorários nos termos do art. 55 da lei nº 9.099/95, por se tratar de recurso contra decisão interlocutória. Intimem-se e, após o trânsito em julgado, devolvam-se os autos ao juízo de origem. É como voto.